2.1.4.2.Rivaroxaban(如 Xarelto)(101/1/1、102/2/1、103/5/1、104/12/1、105/5/1、110/7/1、111/2/1、112/3/1、115/10/1)

限用於

1.靜脈血栓高危險(符合下列條件之一)病患,接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時,預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE),限用 10mg 錠劑,每日一粒,人工髖關節手術術後治療,最多 5 週;人工膝關節手術術後治療,最多 2 週:(112/3/1)

(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史(須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程)之病患;

(2)經靜脈超音波檢查(Venous ultrasonography)或靜脈攝影(Venography)檢測,診斷為靜脈血栓症之病患。(112/3/1)

2.18 歲以上非瓣膜性心房纖維顫動病患,須符合下列條件之一:(102/2/1、103/5/1、105/5/1、111/2/1、112/3/1)

(1)曾發生中風或全身性栓塞。

(2)左心室射出分率小於 40%。

(3)有症狀之心臟衰竭:收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。

(4)75 歲以上。(111/2/1)

(5)50 歲以上未滿 75 歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。(111/2/1、112/3/1)

(6)每日 1 次,每次限 1 粒。(103/5/1)

(7)排除標準:

Ⅰ.病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。

Ⅱ.14 天內發生中風。

Ⅲ.收案前的 6 個月內發生嚴重中風。

Ⅳ.有增加出血風險的情況。

Ⅴ.肌酸酐清除率小於 15mL/min。

Ⅵ.活動性肝病和懷孕。

3.治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞(103/5/1、104/12/1):

(1)須經影像學或血管超音波檢查診斷。

(2)第 1 日至 21 日,每日早晚各一次,每次限用一粒。

(3)第 22 日起,每日一次,每次限用一粒,每 6 個月評估一次。

4.Rivaroxaban 2.5mg 限與 aspirin 併用,可用於發生缺血事件高危險族群之冠狀動脈(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人,以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件(Atherothrombotic events):(110/7/1、115/10/1)

(1)高風險的動脈粥狀硬化須符合 2 年內曾經發生下列心血管事件之一:(110/7/1、115/10/1)

Ⅰ.心肌梗塞。

Ⅱ.多支血管冠狀動脈疾病(Multivessel CAD)。(115/10/1)

Ⅲ.多血管床疾病(polyvascular disease)。(115/10/1)

Ⅳ. 接受血管再通術(revascularization),包括:左主冠狀動脈(left main)、分岔處放過兩支以上支架(bifurcation stenting with ≥2 stents implanted)、慢性全阻塞(CTO, chronic total occlusion)、最後一條通暢血管接受支架置放(stenting of last patent vessel)。(110/7/1、115/10/1)

Ⅴ.使用抗血小板治療下仍發生支架內血栓的病史。(115/10/1)

Ⅵ.動脈硬化相關的缺血性腦中風。

(2)高風險的症狀性周邊動脈硬化須符合下列條件之一:(110/7/1、115/10/1)

Ⅰ.曾經接受過主動脈股動脈(aorto-femoral)或下肢繞道手術；髂動脈、股動脈及膝下動脈(iliac or infrainguinal)接受經皮動脈血管造型整形術(PTA)。

Ⅱ.下肢或足部因動脈血管疾病所造成的截肢或壞疽。

Ⅲ.有間歇性跛行的病史並經血管攝影術或都卜勒超音波等非侵入性測試有顯著的周邊動脈狹窄(>50%)。(110/7/1、115/10/1)

(3)限 Rivaroxaban 2.5mg，每日 2 次，每次限用 1 粒。

(4)不得合併雙重抗血小板(DAPT)藥物、P2Y12 抑制劑(如 clopidogrel、ticagrelor 或 prasugrel)、cilostazol 或其他抗凝血劑(anti-coagulant，如 warfarin)。